

# **CARDIOPATÍA CONGÉNITA**

La cardiopatía congénita afecta a 1.8 de cada 100 nacidos vivos en el mundo, según el análisis más completo disponible sobre la carga global de enfermedad [1]. En 2017 causó 261,247 muertes, de las cuales el 69% ocurrió antes del primer año de vida [1] una concentración que por sí sola debería bastar para justificar cualquier esfuerzo de detección temprana. La cifra ha ido cambiando con el tiempo, pero no del modo que la intuición sugeriría: un metaanálisis sobre 260 estudios y más de 131 millones de nacimientos encontró que aproximadamente el 93.4% del aumento observado en la prevalencia mundial es atribuible a mejoras en la detección, no a que existan hoy más niños enfermos que hace cincuenta años [2]. El mundo no está produciendo más cardiopatías: está, lentamente y de forma desigual, aprendiendo a verlas.

Desigual porque la misma revisión revela una asimetría que interesa directamente a este proyecto: de 260 estudios que sostienen el conocimiento mundial sobre esta enfermedad, Sudamérica aporta sólo nueve, y menos del 0.5% de la muestra total [2]. La región que necesita esta evidencia con más urgencia es la que menos ha contribuido a generarla. Y el informe de carga global de enfermedad añade un dato más inquietante todavía: entre 1990 y 2017, América Latina Andina y África Central/Subsahariana Oriental fueron las únicas dos regiones del planeta donde la mortalidad infantil por cardiopatía congénita aumentó, mientras el resto del mundo la reducía [1].

A nivel nacional, un estudio sobre el Sistema Informático Nacional de Defunciones, publicado en 2024 en coautoría entre la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Clínica Mayo, encontró que Perú registra 70.6 muertes por cardiopatía congénita por cada 100,000 nacidos vivos, con una mediana de edad de muerte de apenas un mes de vida, y con mortalidad significativamente concentrada en los Andes y en las instituciones operadas por el MINSA [4]. Los diagnósticos se concentran en Lima y en zonas de baja altitud, no porque haya menos enfermedad en la sierra, sino porque ahí es donde existe la infraestructura para detectarla [5]. El mismo estudio documenta que las visitas ambulatorias por esta causa aumentaron 20.4% en veinte años, mientras la mortalidad general permaneció prácticamente constante [5]: el sistema está viendo más, pero no está salvando más. El cuello de botella no está en el diagnóstico, está después de él.

La evidencia más reciente, sobre una cohorte del propio Instituto Nacional Materno Perinatal, cuantifica la magnitud exacta del problema en el Perú de hoy: una de cada 400 gestaciones termina en un recién nacido con cardiopatía congénita crítica [6]. Y revela, con una crudeza que ningún otro dato de este documento iguala, por qué detectar a tiempo no basta si el sistema no puede sostener lo que detecta: dos de cada veintisiete recién nacidos en riesgo, atendidos en instituciones del MINSA, murieron dentro de las primeras veinticuatro horas de vida, pese a contar ya con protocolos de detección temprana implementados [6]. En todo el territorio nacional existen, según ese mismo estudio, sólo dos centros con capacidad quirúrgica para cardiopatía congénita neonatal, y ambos están en Lima [6].

## **Referencias**

- [1] GBD 2017 Congenital Heart Disease Collaborators, "Global, regional, and national burden of congenital heart disease, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017," *Lancet Child Adolesc. Health*, vol. 4, no. 3, pp. 185–200, 2020.
- [2] Y. Liu, S. Chen, L. Zühlke, G. C. Black, M. Choy, N. Li, and B. D. Keavney, "Global birth prevalence of congenital heart disease 1970–2017: updated systematic review and meta-analysis of 260 studies," *Int. J. Epidemiol.*, vol. 48, no. 2, pp. 455–463, 2019.
- [3] A. Olórtégui Yzú et al., "Incidencia estimada de las cardiopatías congénitas en niños menores de 1 año en el Perú," *An. Fac. Med.*, vol. 68, no. 2, pp. 113–124, 2007.
- [4] J. Arriola-Montenegro et al., "Congenital heart disease-related mortality during the first year of life: The Peruvian experience," *Int. J. Cardiol. Congenit. Heart Dis.*, vol. 19, art. 100557, 2024.
- [5] A. Tauma-Arrué et al., "Trends in outpatient visits and deaths due to congenital heart defects in Peru," *Int. J. Cardiol. Congenit. Heart Dis.*, vol. 7, art. 100334, 2022.
- [6] J. Carhuayo-Chura et al., "Short-Term Results of Early Detection of Critical Congenital Heart Disease: The Peruvian Maternal Perinatal Experience," *JACC Adv.*, 2025.